ДЕЙСТВИЯ ВРАЧА РЕАНИМАТОЛОГА

ПРИ ОТСУТВИИ ВРАЧА - ПСИХИАТРА

ОТРАВЛЕНИЕ ПСИХ.АКТИВ. ВЕЩЕСТВАМИ

АЛКОГОЛЬ
ОПИОИДЫ
КАННАБИОИДЫ
СНОТВОРНЫЕ
КОКАИН
ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫ

РАССТРОЙСТВА ПСИХИКИ ПОСЛЕ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ (ДО14 ДНЕЙ)

ФИКСАЦИЯ

ДИАЗЕПАМ
В\В БОЛЮСНО 5 МГ, КАЖДЫЕ 2-5 МИН ДО MAX 0,25 mg НА 1 kg

БЕЗ ЭФФЕКТА

ГАЛОПЕРИДОЛ 10 МГ – MAX РАЗОВО
(ДО 30 мг В СУТКИ)

СИНДРОМ ОТМЕНЫ 48-72 ЧАСА ПОСЛЕ АЛКОГОЛИЗАЦИИ

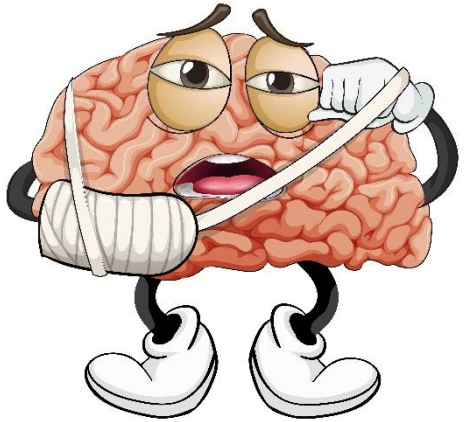
ТИАМИН 200-500 МГ

МИДОЗАЛАМ
START- 1 мг в\в
Далее каждые 5 мин
MAX до 3.5 мг

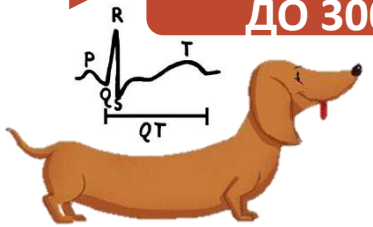
ДИАЗЕПАМ В\В БОЛЮСНО 5 МГ, КАЖДЫЕ 2-5 МИН ДО MAX 40 mg в сутки

БЕЗ ЭФФЕКТА

ГАЛОПЕРИДОЛ 1-2 МГ КАЖДЫЕ 2-4ч (ДО 10 мг В СУТКИ) ПРИ > 65 ЛЕТ – 5 МГ в сутки



ТИАПРИД В\В ДО 300 МГ В СУТ



ЕСЛИ В АНАМНЕЗЕ СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ→КАРБАМАЗЕПИН ДО 800 МГ /СУТ (START ПО 200 мг Х 2 Р\С)

ДЕЛИРИЙ ПОЖИЛЫХ

↓

МЕЛАТОНИН
3 мг перед сном

↓

КВЕТИАПИН
25 мг в сутки

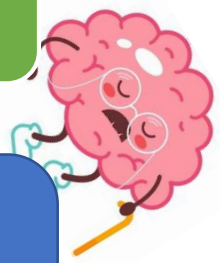
↓

БЕЗ ЭФФЕКТА

↓

ГАЛОПЕРИДОЛ КАПЛИ
От 5 до 10 капель

ДЕМЕНЦИЯ



Тиаприд 50мг\мл
1 мл – 2 мл
в\м
Max 300 мг

КВЕТИАПИН
12.5 мг
на ночь
до 200 мг в сут.
↑ каждые 48 ч

ГАЛОПЕРИДОЛ
до 5 КАПЕЛЬ
ИЛИ
ПАРЕНТЕРАЛЬНО ДО 5 МГ